

SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS. TRASTORNO SOMATOMORFO. HIPOCONDRIASIS. TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN. TRASTORNO PSICOSOMÁTICO DEL DOLOR

Forcelledo Cristina, Manso Carmen

INTRODUCCIÓN

El término “somatización” engloba una serie de entidades que tienen por punto en común la queja somática que no se explica de un modo congruente con una enfermedad médica determinada. Estos pacientes acuden a urgencias con mucha frecuencia, demandando exploraciones y diferentes pruebas que justifiquen de algún modo su dolencia, provocando en muchos casos una reacción de contratransferencia negativa y, en definitiva, una frustración que es compartida entre el médico y el propio paciente.

Se estima la prevalencia de estas patologías entre un 17-50% dependiendo de los estudios consultados y las características sociodemográficas que se tengan en cuenta, hablando de una elevada frecuencia de presentación en menor o mayor grado. Se encuentra una correlación positiva con el sexo femenino, y un mayor riesgo en situaciones de bajo nivel socioeconómico, así como la pertenencia a minorías étnicas. Los niños que han presenciado la somatización en su ámbito familiar pueden mimetizar el modelo, y la dificultad para expresar verbalmente las emociones ha sido relacionada con un mayor riesgo de reflejo en la corporalidad.

Se considera controvertido el atribuir la etiología de estas patologías a una causa puramente psiquiátrica, sugiriéndose que podría tratarse de un síndrome multisintomático que complica la presentación de una enfermedad médica.

Cabe resaltar que, a raíz de la publicación del reciente manual DSM-V, la terminología ha variado y en el momento actual se les denomina “síntomas somáticos y trastornos relacionados”. Este epígrafe engloba las siguientes entidades:

- Trastorno de síntomas somáticos, que aúna los antes llamados “trastorno somatomorfo”, “trastorno de somatización” y “trastorno psicossomático del dolor”.
- Trastorno de ansiedad por enfermedad, conocido como “hipocondriasis”.
- Trastorno de conversión
- Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas
- Trastorno facticio.

Salvo el trastorno de conversión, que se tratará aparte, abordaremos en este capítulo cómo diagnosticar y manejar este tipo de casos en el servicio de urgencias hospitalarias.

DIAGNÓSTICO

Trastorno de síntomas somáticos.

Los criterios DSM-V exigidos para el diagnóstico de esta entidad son los siguientes:

- Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria.
- Pensamientos, sentimientos o comportamiento excesivos, relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud.
- Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente (generalmente, durante más de 6 meses).

- La preocupación no se explica mejor por otra patología médica u otro trastorno mental.

Cabe recordar que la queja somática en cuestión es real, no fingida. Las repercusiones afectiva y comportamental llamativas son las que deben poner en alerta sobre la presencia de esta entidad. La constelación sintomática que aqueja al paciente puede ser de lo más variada y, en muchos casos, inespecífica. Los que se dan de forma más frecuente son el dolor (cefaleas, artralgias, abdominalgias, disuria...), los gastrointestinales (gases, náuseas, vómitos, diarrea...), cardiopulmonares (dolor torácico, mareos, disnea, palpitaciones...), neurológicos (quejas mnésicas, síncope, debilidad muscular...) y sexuales (anorgasmia, dismenorrea, dispareunia...).

Una vez establecido el rol de enfermo, pueden llegar a una limitación funcional severa que requiera incluso el cuidado por parte de terceras personas. El diagnóstico de esta entidad constituye una tarea delicada, puesto que por lo general se muestran reticentes a considerar una atribución psicológica, aunque sea parcial, de su malestar. Suelen ser pacientes conocidos en los servicios de urgencias por las múltiples consultas que demandan, bien sea por un mismo síntoma o bien por quejas cambiantes. Por lo general, son los médicos de urgencias y de cabecera quienes conocen ampliamente a estos sujetos, siendo imprescindible descartar previamente una patología somática que justifique los síntomas, así como un manejo razonable de los recursos que solicitan.

Trastorno de ansiedad por enfermedad.

Antes denominada “hipocondriasis”, se cambió su título en el DSM-V por el significado peyorativo de uso popular que arrastraba el término. Los criterios exigidos por el DSM-V para su diagnóstico son los siguientes:

- Preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave.
- No existen síntomas somáticos o, si están presentes, son leves. Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentarla, la preocupación es claramente desproporcionada.
- Grado elevado de ansiedad acerca de la salud; el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud.
- Comportamientos excesivos relacionados con la salud, o evitación por mala adaptación.
- La preocupación está presente al menos 6 meses, pero la enfermedad específica temida puede variar en ese período de tiempo.
- La preocupación no se explica mejor por otro trastorno mental.

Nuevamente hablamos de pacientes que frecuentan los servicios de urgencias demandando pruebas y exploraciones que apacigüen su malestar, aunque generalmente lo hacen de forma temporal. Los pacientes suelen exponer un temor desproporcionado y escasamente fundado por padecer enfermedades tales como el cáncer o distintas ETS (sífilis, SIDA...) sin llegar a un carácter delirante.

La presencia de patologías de este tipo en personas cercanas al paciente (pareja, padres, hermanos, amigos...) puede disparar las cogniciones, y las conductas tienden a tener un carácter desadaptativo evidente: rituales del espectro obsesivo-compulsivo, aislamiento domiciliario, disminución de actividades... Es importante realizar una detallada historia clínica que nos oriente a las posibles causas y repercusiones individuales del malestar, y realizar un diagnóstico diferencial con entidades afectivas o rasgos de personalidad disfuncionales comórbidos. Se otorgará el diagnóstico de “trastorno de ansiedad por enfermedad” cuando el síntoma príncipes es el de la preocupación reiterativa por contraer o padecer una enfermedad grave.

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas (FPIOAM)

A continuación, se exponen los criterios DSM-V para el diagnóstico de esta condición:

- Un síntoma o afección médica general está presente.
- Los factores psicológicos o conductuales afectan negativamente a la condición médica en una o más de las siguientes maneras: plantean riesgos adicionales para la salud del paciente, agravan la fisiopatología subyacente de la patología (desencadenan o agravan los síntomas), afectan el curso de la condición médica, interrumpen el tratamiento de la enfermedad.
- Otros trastornos mentales no explican mejor los factores psicológicos o de comportamiento.

Hablamos en este caso de pacientes que pueden acudir al servicio de urgencias con una entidad médica diagnosticada, pero que la evolución es tórpida debido a conductas desadaptativas del afectado. Entre estos factores podemos encontrar mecanismos de afrontamiento patológicos, como la regresión o la negación, por ejemplo. No es la entidad más frecuente por la que se avise al profesional de psiquiatría de urgencias, y su presentación sin comorbilidad afectiva añadida (depresión, trastorno de pánico, duelo...) es rara. Su diagnóstico es delicado y debe realizarse una historia clínica detallada.

Trastorno facticio

Los criterios diagnósticos requeridos por el DSM-V para su diagnóstico son los siguientes:

- Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o la inducción de la lesión o enfermedad, asociada con el engaño identificado.
- El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado.
- El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensas externas obvias.
- El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico.

La clave de esta entidad que la distingue de la simulación, principal reto de diagnóstico diferencial, es la ausencia de un beneficio secundario evidente: ganancia económica, evitar un proceso criminal, evitar obligaciones... El beneficio es fundamentalmente primario, en la apropiación de rol de enfermo, y suele coexistir con rasgos desadaptativos de personalidad o procesos afectivos.

Estos pacientes se presentan en los servicios de urgencias con una actitud generalmente demandante, querulante, resaltando su posición como enfermo. Suelen tener algunos conocimientos médicos que exponen de forma activa, y los síntomas presentados pueden ser problemas de cicatrización de heridas, infecciones, sangrados, laceraciones o problemas gastrointestinales.

Para el diagnóstico se requiere la identificación objetiva de los comportamientos de falsificación de enfermedad y cabe explorar los posibles motivos subyacentes de la consulta en cuestión. Para ello es importante entrevistar a los acompañantes del paciente con el fin de recabar el máximo de información posible.

TRATAMIENTO

La detección y abordaje de este grupo de pacientes en urgencias supone un verdadero reto para el profesional médico. La actitud general va encaminada al rechazo por parte del usuario de aceptar que una condición psicológica pueda ser la responsable de su dolencia. No obstante, se

solicitarán las pruebas médicas que se consideren oportunas en cada caso, antes de informar al personal de psiquiatría sobre el cuadro que se presente. Es importante resaltar que no se debe caer en una yatrogenia, realizando exploraciones o tratamientos que no sean estrictamente necesarios, y explicar al paciente con actitud serena y empática la sospecha etiológica.

En cuanto al abordaje por el psiquiatra de urgencias, se debe optar por la combinación entre la farmacología y la intervención en crisis psicoterapéutica.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

- **BENZODIACEPINAS:** preferiblemente de vida media larga, como diazepam o clorazepato dipotásico, para el tratamiento agudo de sintomatología relacionada con la ansiedad. No se debe olvidar que su uso debe ser restringido y en ningún caso sustituible por una psicoeducación sobre el trastorno.
- **ANTIDEPRESIVOS:** se deben iniciar o ajustar sobre el tratamiento ya prescrito, en caso de sospechar patología somatomorfa con comorbilidad afectiva. Optaremos por los de perfil serotoninérgico (sertralina, escitalopram...) en primera instancia, considerando en caso de refractariedad el paso a duales (duloxetina, veflafaxina, desvenlafaxina). Estos últimos tienen además la ventaja, en algunos casos, de poseer un cierto efecto antiálgico (especialmente, la duloxetina). Es importante revisar la patología somática comórbida a fin de detectar posibles contraindicaciones para el uso de estos fármacos.
- **ANTICOMICIALES:** fármacos como la carbamacepina, gabapentina y pregabalina deben considerarse como coadyuvantes sintomatológicos, especialmente en casos refractarios, dado su perfil contra el dolor neuropático y la reducción de ansiedad.

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN URGENCIAS

Resulta fundamental informar tanto al paciente como a sus familiares de la sospecha etiológica y de la necesidad de un seguimiento por parte de los servicios de salud mental comunitarios. Se debe explicar de forma respetuosa la sintomatología y en ningún caso invalidar la respuesta emocional que pueda suponer en el paciente esta noticia. No olvidemos que lo habitual será una actitud resistente y que la intervención que se haga determinará en buena parte la vinculación del paciente a los servicios comunitarios. Lo primordial será tranquilizar sobre síntomas menores y repasar aquellos que puedan ser tributarios de una nueva exploración de urgencia.

Dentro de lo posible, es recomendable dar al paciente herramientas de gestión de la ansiedad para mejorar la adherencia a sus dispositivos de referencia y empoderarlo en el proceso de recuperación. Sus acompañantes también deben ser conocedores de las mismas, haciéndolos partícipes de la intervención.

A nivel comunitario, se procederá al abordaje disponible que mejor se adecúe al paciente en concreto. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene un mayor número de estudios de eficacia para estas entidades, si bien la psicoeducación, la terapia familiar y la psicoterapia psicodinámica han sido utilizadas con buenos resultados. Las terapias de tercera generación (mindfulness, aceptación y compromiso, compasión...) están en auge en el momento actual con numerosos estudios que avalan su eficacia. Todas ellas pueden administrarse en formato grupal.

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE PASAR EN URGENCIAS

- Los síntomas somáticos y trastornos relacionados son un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias. Se debe realizar una exploración somática cuidadosa y sin caer en pruebas innecesarias.
- Por lo general, los pacientes se muestran reticentes a la perspectiva de padecer una dolencia mental, y el manejo supone un reto profesional.
- Es fundamental explicar y tranquilizar de forma respetuosa y empática sobre la sintomatología, a fin de vincular al paciente a los servicios de salud mental comunitarios.
- No debe omitirse la posibilidad de una comorbilidad afectiva, que se debe explorar con detenimiento.
- El tratamiento incluirá las benzodiacepinas en momentos de crisis, el inicio de antidepresivos serotoninérgicos o duales, y considerar como coadyuvantes fármacos anticomiciales.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). American Psychiatric Association: Arlington;2013.
- Barsky AJ, Ettner SL, Horsky J, Bates DW. Resource utilization of patients with hypochondriacal health anxiety and somatization. Med Care 2001; 39:705-15.
- Gelauff J, Stone J, Edwards M, Carson A. The prognosis of functional (psychogenic) motor symptoms: a systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85:220-6.
- Hellman CJ, Budd M, Borysenko J et al. A study of the effectiveness of two group behavioral medicine interventions for patients with psychosomatic complaints. Behav Med 1990; 16:165-73.
- Fehnel CR, Brewer EJ. Munchausen's syndrome with 20-year follow up. Am J Psychiatry 2006; 163:547.
- Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet 2007; 369:946-55.
- Greeven A, van Balkom AJ, Visser S et al. Cognitive behavior therapy and paroxetine in the treatment of hypochondriasis: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007; 164:91-9.
- Guía de buena práctica clínica en atención primaria de ansiedad y depresión y síntomas somáticos (online).